جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فايزه فراج محمد دهشور
المحافظة : سوهاج **الحي / المدينة :** المراغه **العنوان :** الشورانيه
رقم البطاقة : 28108282600901 **رقم التليفون :** 01205741115 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-08-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي محوسب مع صبغة للرقبة والصدر والبطن والحوض [11128] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فايزه فراج محمد دهشور
National ID: 28108282600901

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT scan of the neck, chest, abdomen, and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]


٢٨١٠٨٢٨٢٦٠٠٩٠١
٢٠٢٢/٠٩
لاتعمل
انثى مسلمة متزوجة
احمد على محمد
١٠ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١١

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	فايزه فراج محمد دهشور	**Case No.**	**385515**
Sex/Age	**Female 45 Y**	**Patient No.**	**29015**
Registered Date	**19/9/2026 09:14:24 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**29/9/2026 11:57:32 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:30:28 AM**	**Pathology No.**	**2963/26**

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/09/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.3 cm & 0.9 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Present, solid and cribriform low and intermediate grade.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسى انترناشونال – مصر معمل الباثولوجى
جوستاف روسي

Patient Name	**فايزه فراج محمد دهشور**	**Case No.**	**385515**
Sex/Age	**Female 45 Y**	**Patient No.**	**29015**
Registered Date	**19/9/2026 09:14:24 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**29/9/2026 11:57:32 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:30:28 AM**	**Pathology No.**	**2963/26**

- Her2: Low (score 1+)
- Ki67%: 15%.

***Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
**** Scoring system: "Her2"***
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

اسم المريض بالإنجليزية: Faizah Farag Mohamed	كود المريض: 99260
تاريخ التقرير: 2026/09/13 12:37:47 PM	السن: ٤٥ سنة

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 46 years old female patient with left breast lump.

Detailed Findings

Left breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- The left breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion located at upper inner regior. easuring about 2.5 x 2.2 x 2 cm at AP, TS and CC respectively and about 7 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined spiculated hypoechoic mass lesion located at 11 ° clock position and measures about 20 x 19 mm at its maximum diameters
- Normal nipple/areolar complex.
- Enlarged axillary lymph node at level I with effaced hila, measures about 6.2 x 4.1 mm.

Right breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UIQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph node as described for tru cut biopsy.**
- **Right breast (BIRADS 1): Normal study.**

Much obliged,
Dr. Rania Mostafa
Dr. Hedaya Nour, MD

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Faizah Farag Mohamed :اسم المريض بالإنجليزية	99260 :كود المريض
2026/09/13 12:37:47 PM :تاريخ التقرير	السن: ٤٥ سنة

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 46 years old female patient with left breast lump.

Detailed Findings

Left breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- The left breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion located at upper inner region measuring about 2.5 x 2.2 x 2 cm at AP, TS and CC respectively and about 7 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined spiculated hypoechoic mass lesion located at 11 ° clock position and measures about 20 x 19 mm at its maximum diameters
- Normal nipple/areolar complex.
- Enlarged axillary lymph node at level I with effaced hila, measures about 6.2 x 4.1 mm.

Right breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UIQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph node as described for tru cut biopsy.**
- **Right breast (BIRADS 1): Normal study.**

Much obliged,
Dr. Rania Mostafa
Dr. Hedaya Nour, MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



فايزه
فراج محمد دهشور
الشورانيه
مركز المراغة - سوهاج

١٩٨١/٠٨/٢٨

٢ ٨١ ٠٨ ٢٨ ٢٦ ٠٠٩ ٠١

JN8288763

عنى
٠١٠٥٧٤١١١٥

٢٨١٠٨٢٨٢٦٠٠٩٠١ ٢٠٢٢/٠٩
لاتعمل

أنثى مسلمة متزوجة
احمد على محمد
١٠ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/١١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Faizah Farag Mohamed :اسم المريض بالإنجليزية	99260 :كود المريض
2026/09/13 12:37:47 PM : تاريخ التقرير	السن: ٤٥ سنة

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 46 years old female patient with left breast lump.

Detailed Findings

Left breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- The left breast shows middle 1/3 ill-defined spiculated dense mass lesion located at upper inner region measuring about 2.5 x 2.2 x 2 cm at AP, TS and CC respectively and about 7 cm from the nipple.
- **Ultrasound** revealed ill-defined spiculated hypoechoic mass lesion located at 11 ° clock position and measures about 20 x 19 mm at its maximum diameters
- Normal nipple/areolar complex.
- Enlarged axillary lymph node at level I with effaced hila, measures about 6.2 x 4.1 mm.

Right breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UIQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph node as described for tru cut biopsy.**
- **Right breast (BIRADS 1): Normal study.**

Much obliged,
Dr. Rania Mostafa
Dr. Hedaya Nour, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :14-9-2026

جهه الاصدار :فرع الجيزة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) فايزه فراج محمد بطاقة رقم 28108282600901

تليفون رقم: لايوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :14-9-2026

الموظف المختص
الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع الجيزة
مي ابو الخير
ادارة النظم والمعلومات
قسم المعلومات

إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2078012

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]